未来の介護(SOMPO流の介護)

カスタムメイドケアカンファレンスとegaku

目次

egakuとカスタムメイドケア ---------- 1
egakuとカスタムメイドケアカンファレンス ---- 2
egakuとは ---------- 3
egakuの活用場面 ---------- 4
egakuを使ってみよう ---------- 5
カスタムカンファを実施しよう ー準備ー ----- 6
情報収集シート記載のポイント ---------- 7
カスタムカンファを実施しよう ー手順ー ------- 8

未来の介護推進部

人材開発部

IT企画部

2025年3月

最終更新日：2025.3.5

egakuとカスタムメイドケア

はじめに

この冊子は、 SOMPOケアが開発したソフトウェア「**egaku**」の機能を活用したカスタムメイドケア、特にカスタムメイドケアカンファレンスでの活用方法を記しています。 egakuは、アセスメントやケアプラン、業務管理表、介護記録からデータを収集し、生産性・品質の向上に役立てられるよう設計されたソフトウェアで、**「カスタムメイドケアサポート」**というアプリです。

まずは管理者がその機能を十分に理解してください。そしてケアマネジャー・ナースをはじめ、egakuを活用する職員をサポートし、説明するのにこの冊子を役立ててください。

「人間尊重」とカスタムメイドケア

「カスタムメイドケアサポート」は、ご利用者さま一人ひとりのケアをより最適化する機能を持っています。これらは「カスタムメイドケア」をより適切に実践するためのものです。

SOMPOケアの理念は「人間尊重」にあり、理念を具現化する指針として行動指針があります。

行動指針1：私たちはご利用者さまの「できること」に着目して自立を支援し、カスタムメイドケアを通してQOLの向上を目指します

「カスタムメイドケア」とは、虎の巻やカスタムメイドケアガイドラインに記載されている通り、「ご利用者さま一人一人に寄り添った個別ケア」の実践のこと。ご利用者さまの生活歴や大切にされていること、身体機能、既往歴、服薬内容等々、すべてを含めてその方に“**必要なケア**”を実践することです。

どこでどんな風に暮らされてきたんだろう？

ADLと「できること」は？

ご本人の意欲や願いは？

食事量は？排便は？

服薬内容は？

痛みの訴えは？

どんな気持ちでいらっしゃるんだろう

カスタムメイドケアの基礎はアセスメント

別冊 ガイドライン

カスタムメイドケアの詳しい内容は**「カスタムメイドケアガイドライン」**をご参照ください

egakuとカスタムメイドケアカンファレンス

適切な状態を保つために

“**必要なケア**” の根拠はアセスメントから導かれます。アセスメントでは、その方の「できること」に着目し、「能力」を評価して「必要なケア」を考えます。そしてご本人の希望や生活歴も含めて検討した「援助内容」がケアプランに記載され、業務管理表に反映されて実行されている、これが“**必要なケアが適切に実施されている**”状況と言えます。

ご利用者さまの状態は日々変化します。その中で“**必要なケアが適切に実施されている**”状況を保ち続けるためには、**記録によって援助を「見える化」し、援助の過不足の調整や問題解決を行い続けるPDCAサイクルを回す**ことと、**「カスタムメイドケア」を意識したカンファレンス（以下カスタムカンファ）をホームで定期的に開催する**ことが求められます。

カスタムカンファは「アセスメント」「ケアプラン」「実施」「再評価」「計画変更」を回していくPDCAサイクルの、「再評価」から「アセスメント」までを担います。ご利用者さまをアセスメントし、**予定表と実際の援助が一致するよう調整し、その方に本当に必要なケアが実施されるよう、適切なケアプランを作っていく場**です。**「援助時間が合っていない」「自立支援ではなく過剰介護になっている」「職員間で援助方法がバラバラ」**などの、**援助のムリ・ムダ・ムラを削っていくプロセス**であり、「未来の介護」が目指す**品質の維持と生産性向上の両立**にも欠かせません。

問題解決や分析には、まず問題点をしっかりと把握することが大切です。そこで役立つのが**介護記録**から得られる**データ、すなわち**「**egaku**」です。カスタムカンファでは、**egaku**のデータを活用していきましょう。

POINT!

アセスメント時、ケアプラン作成時に、egakuのデータを活用しよう！
カスタムカンファを開き、egakuのデータを活用して援助時間の適正化を図ろう！

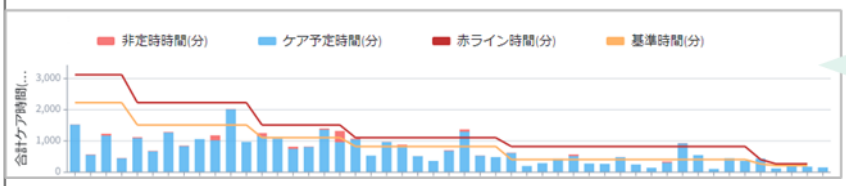
この冊子ではegakuの概要やカスタムメイドケアカンファレンスについて説明しています。

egakuとは

egakuは、SOMPOケアが独自に開発した**ソフトウェア**です。
介護記録からデータを収集し、生産性・品質の向上に役立てられるよう設計されています。
ここでは、カスタムカンファで活用する「カスタムメイドケアサポート」について解説します。

カスタムメイドサポートの機能

- **ご利用者さまごとの「援助予定時間」と「実際の援助時間」のズレが一目で分かる**
- **「援助過剰」「非定時（排泄のみ）」など、個別にアラートを表示**
- **体調不良のご利用者さまが一目でわかる**
- **「高体温」「食事量少」など、個別にアラートを表示**



介護度別に援助の過不足が可視化され、区分変更やプランの見直しに繋がる。

過剰：援助過剰　中止：援助中止　排泄：非定時(排泄のみ)　以外：非定時(排泄以外)　事故：事故ヒヤリ

要介護度	年齢	援助検討アラート	体調異常(前日)	体調異常(2週間)	短期目標終了日
要介護1	88	事故 中止 過剰 以外	なし	食事量少	2025年[illegible]
要介護4	92	事故	食事量少	食事量少	2025年7月
要介護4	90	排泄	食事量少	食事量少	2025年2月28日
要介護1	87	なし	なし	高体温	2025年8月31日
要介護1	74	なし	なし	なし	2025年5月31日

ご利用者さまのアラートや短期目標期間が一覧で表示され、援助見直しにつながる。

援助検討アラート

- **過剰** …**援助過剰：** 直近2週間の援助予定時間が、現行の介護度より1段階重い要介護度の基準時間以上
- **中止** …**援助中止：** 直近2週間の援助中止記録件数が援助予定件数に対して10%以上
- **排泄** …**非定時（排泄のみ）：** 直近2週間で非定時の排泄援助が28件以上
- **以外** …**非定時（排泄以外）：** 直近2週間で排泄以外の非定時の直接援助が28件以上
- **事故** …**事故ヒヤリ：** 直近2週間に事故報告記録が2件以上

カスタムカンファで **egaku** を分析し、課題を解決していきましょう！

体調異常（前日/2週間）

- **高体温** …（前日or直近2週間）37.0℃以上の記録あり
- **体重減** …（前日or直近2週間）の体重記録があり、かつ3%以上の体重減少あり
- **食事量少** …（前日or直近2週間で1回以上）の主食副食摂取量の平均が7割5分以下

短期目標終了アラート

- **年月日** …（年月日が赤色表示）短期目標終了日超過
- **年月日** …（年月日が青色表示）0日～31日後
- **年月日** …（年月日が緑色表示）32日～62日後

期限切れがないか、次回の対象者はどのご利用者さまか、確認しましょう！

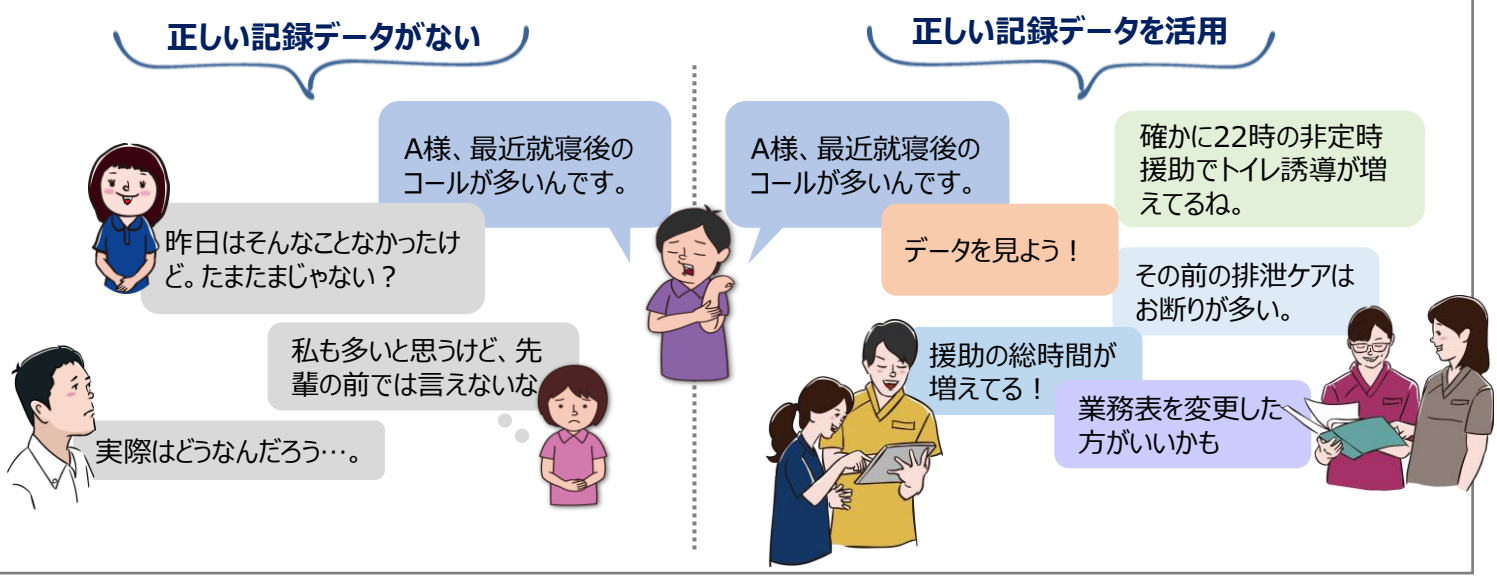
egakuの活用場面

課題発見をアクションへつなげる

egakuの仕組みを簡単に示すと、以下のようになります。
「データ」として収集されたケアスタッフの介護記録（❶）がegakuの各ソフトウェアで整理・分析され、表示されます。それにより管理者やケアマネジャーが問題を把握し（❷）、職員と共有して原因の分析や話し合いを実施することで（❸）、改善のためのアクションを起こすことが可能になります。
またデータをもとにすることで、医療連携やご家族との課題の共有もスムーズになります（❹）。

データで問題を「見える化」する

上の図で重要なのは、**❶ケアスタッフによる記録入力**です。「援助時間の記録」が、egakuの「データ」となるからです。データがないと、問題は人それぞれの判断や感覚で語られるため、客観的な判断ができません。記録をデータとして活用することで、現在起こっている問題が「見える化」され、スタッフ同士で共有しやすくなり、解決策を考えやすくなります。



egakuを使ってみよう

egakuを申請する

egaku はガルーンから申請します

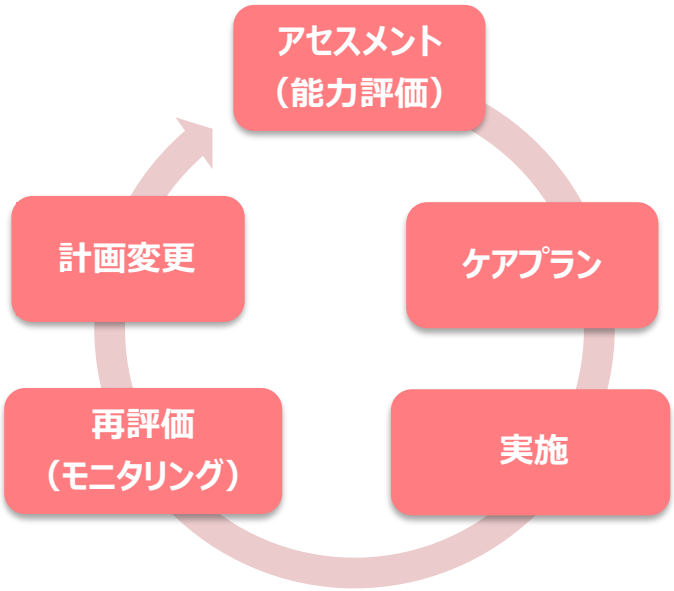
1. ガルーントップページ＞ 申請書 ＞「申請する」をクリック ＞「ワークフロー」をクリック ＞ 「IT関連（WiFi、・・・）」をクリック ＞「**SC05B11_egaku設定申請**」から申請します。
2. 申請に必要な「**担当事業所　事業所番号**」は、ガルーントップページの左端のメニュー＞「施設・事業所一覧」のリンク＞ エクセルデータ から見ることができます。「**指定申請番号(新)**」の番号を入れてください。
3. **ホーム長、副ホーム長、ケアマネジャー、ケアコンダクター**のアカウント申請までしておきましょう。（ケアスタッフ、看護師、栄養士についてはホーム長判断で申請）　複数申請の場合はExcel添付で申請すると便利です。

※原則として、稟議申請Excel作成は各ホームで行い、取りまとめたものを部長か業務部で申請します。

新規・変更・削除	部*	グループ	姓*	名*	表示名(ふりがな)*	ユーザーID*	勤務場所
新規	埼玉千葉本部		テスト	太郎	テスト 知ウ	012345	SOMPOケア　ラヴィーレxx
変更	東京本部	東京中央第2事業部				32748	SOMPOケア　そんぽの家成
変更	東京本部	東京中央第2事業部				30008830	SOMPOケア　そんぽの家成
変更	東京本部	東京中央第2事業部				24526	SOMPOケア　そんぽの家成

カスタムカンファの目的を確認する

egakuは、主にカスタムカンファで活用します。ご利用者さま一人一人に寄り添った個別ケア（カスタムメイドケア）を実践するために大切なのが、PDCAサイクルをしっかり回すことです。その要となるのが**カスタムカンファ**。egakuのデータを活用し、介護の質と生産性向上を目指しましょう。



カスタムメイドケア実践のPDCAサイクル

カスタムカンファの目的❶

「ライン表と現場との動きの乖離をなくす」

①「ライン表」と「実際の援助」の差を確認する

②「モニタリング」として評価を行い、
　アセスメントを修正し、必要に応じてケアプランを変更。

カスタムカンファの目的❷

「自立支援に向けた援助ができる」

カスタムカンファを実施しよう –準備-

ルールに沿って
定期的に
開催しよう！

カスタムカンファの日時・頻度・対象者

【頻度】 月2回　　【所要時間】　原則1時間

1回目（第２週目）

対象者

- ◻ ケアプラン更新者（翌々月プラン更新者）全員
- ◻ 栄養マネジメント「高リスク」対象者
- ◻ 新規利用者・退院者・状態の変化があった利用者
- ◻ 前月の対象者（問題がある場合のみ）
- ◻ **「カスタムメイドケアサポート」**で援助時間のズレ、援助検討アラートが出た方、褥瘡リスク高い方、BPSD顕著な方等

内容

- ✓ 情報収集シートに沿って、**「ライン表」と「現場の乖離」の検討**を行う
- ✓ 状況に応じて**「スケジュールや内容を変更」し、暫定スケジュールを作成**する

2回目（第４週目）

対象者

２週目と同じ

内容

- ✓ 第2週目で検討した暫定スケジュールの確定
- ✓ 「能力向上」のための援助立案
- ✓ 「QOL向上」（楽しみ・生きがい）の援助立案
- ✓ 「栄養ケア・マネジメント」のための援助立案
- ✓ PROMにて検討が必要な方を挙げる（別途取り組みを行う）

カスタムカンファで使用するツール

①アクシストより印刷した直近の「週間スケジュール」

居室担当者が情報収集する際に、該当のご利用者さまにどのような援助が入っているのかを確認するうえで必要な資料となります。
ご利用者さまの週間スケジュールを全員で把握するために、準備にもカンファレンス当日も必要な書類です。

②情報収集シート ⇒ カスタムメイドケアサポートから出力

情報収集シートは、居室担当者が情報収集（手書き）して提出する資料です。

情報収集シートの書き方はp7へ

<出力方法>

1. カスタムメイドケアサポートトップ画面の入居者一覧にて「短期目標期限」でソートするほか、ケアカレンダーで**援助時間にズレがある方**、**栄養マネジメント高リスク対象者**、をピックアップする。

2. ピックアップした対象者の情報収集シート、支援シートを印刷し、「週間スケジュール」とともに居室担当に配布する。情報収集シートは、居室担当者が入力した後、カスタムカンファ出席職員が確認の上、追記を行い、管理者へ提出する。
   ※栄養ケアに関する箇所は、毎月配信されるtableauデータ（10日前後に配信）を参考に、管理栄養士が配属されている事業所では管理栄養士が、それ以外では管理者が記載します。

③対象となる各ご利用者さまの課題などの検討記録（事前議事録）

検討記録には、カスタムメイドケアサポートの内容も反映させます。

情報収集シート記載のポイント

ご利用者さまの一番近くにいるのはケアスタッフ！気になることは自信を持って記載して、カンファで話し合おう！

カスタムメイドカンファレンス情報収集シート

出力日：2024年6月12日(水)

記入者名：

施設名		氏名	要介護2、88歳 ）

	排泄援助ズレ（15分以上）	未実施率	栄養リスク	その他気になること
アラート対象	42% 2024/06/03	5% 2024/06/03	中	

1．援助量等確認事項

援助時間(分)	基準時間(分)	ラインの超過	未実施率	援助時間の過不足	ライン外援助	援助開始時間のズレ
619	413	援助過剰	5%	有・無	有・無	有 無

見直し必要性	その理由（ありでもなしでも）
有 無	援助の実施時間がずれることがある、時折失禁される

2．栄養予測確認事項

栄養リスク	主食（食事内容）	副食（食事内容）	主食（量）	副食（量）	体重
中	常食	常食	7.8 2024/06	4.5 2024/06	37 kg 2024/06/05

BMI	食平均	Alb	褥瘡リスク	体重減少率	飲水（推奨量）	飲水（摂取量）
20.3 2023/11/30・2024/06/05 ※身長日付・体重日付	6.1 2024/06	- g/dl	無	8% 2024/05/08～2024/06/05	869.4 ※身体なしの場合算出不可	331.3 ml 2024/06

管理栄養士(栄養士)の見解	

見直し必要性	その理由（ありでもなしでも）
有 無	夜間睡眠時間が減少傾向、食事量にムラがある。

●見直しの必要性

実際の援助で経験した、**アクシストの「予定」と「実際の援助」にズレが生じている援助内容**を記入します。
情報収集参考シートの「援助量等確認事項」を参照するほか、気になることは他のスタッフにも意見を聞いてみましょう。

●問題点の確認

体調異常アラートが出た利用者は、**食事量少、体重減、高熱の原因など**について確認してみましょう。
また問題点があったときにはまず、**薬が適正か**のチェックが重要です。

4．問題点の確認

問題点	夜間睡眠時間が減っている（平均6時間→4時間） 食事量にムラがある。
確認項目	課題「あり・なし」の理由
薬による生活上の課題 身体的・精神的な疾患による生活上の課題 環境・心理的な問題	1日6種類以上の服薬であり、ポリファーマシーである。 眠前薬でデパスが処方されているが、処方理由が明確でない可能性あり。

項目	気づき
生活歴 行動観察 本人の話 自分だったらどうか	音楽を聴いたり、テレビを見たり、SNSをしたりとお部屋で自分のペースで過ごされている。 他人を気にすることなく,自分のペースで生活したい。 自分のことは可能な限り自分でやりたい。

5．参加に向けた確認

ADL

	屋内での移動	食事動作	排泄の後始末	浴槽の出入り	下衣の着脱	口腔清潔
できる	非実施	独立	独立	一部介助	独立	独立
している	非実施	自立	自立	一部介助	自立	自立

能力向上の可能性	能力向上できそうな援助詳細	排泄の自立 排泄の失敗を減らし、排泄の自立を継続していただきたい
参加制約の軽減に向けて	ホーム内	朝食の後、おいしいコーヒーを飲みたい
	ホーム外	月に1度でも自宅に帰って飼っている犬に会いたい
ご本人に提案したいこと		お薬の点検及び必要に応じた見直し ※デパスの必要性もしくは変更 ※マグミット、センノシド、レシカルボンという便通コンボの必要性確認 ※塗布薬の必要性確認（抗炎症薬複数コンボ）

●気づき

これまでの生活歴や習慣を踏まえ、ご利用者さまが大切にされていることや、日々の暮らしについて記入します。

●参加に向けた確認

上記の援助項目で、**福祉用具、環境整備、援助内容の見直し**により、少しでもご自身でできる活動を提案しましょう。

ご本人の要望をヒアリングし、記入します。 普段の生活で自己決定支援、自立支援に活かしていくほか、Qライン・Qタイムの活用で、ご本人の価値観や楽しみ、希望につながる参加の実現につなげていきましょう。

●ご本人に提案したいこと

援助や薬の見直しのほか、ACPにつながる活動のご提案やQOL向上に寄与するご提案もとても重要です。

カスタムカンファを実施しよう –手順-

p6「対象者」参照

20日頃

すべきこと

対象者ピックアップ

ホーム長（生活相談員）

ケアマネジャー　担当者

❶【**カスタムメイドケアサポート**】トップ画面の入居者一覧にて「短期目標期限」でソートするほか、**援助時間にズレがある方**、**栄養マネジメント高リスク対象者**、をピックアップする。
❷ピックアップした利用者の「**情報収集シート**」を印刷し、**週間スケジュール**とともに居室担当に配布する。

21日～月末

情報収集

居室担当　参加職員

栄養士　看護師

❶ご利用者さまを観察し、担当としての意見を**「情報収集シート」に記載**する。
他スタッフにもヒアリングし、提案や意見は「その他気になること」に記載。
❷**カンファ参加職員に提出**する。
✓参加職員は不明点は居室担当に確認し、必要な追記をして管理者に提出。
✓栄養欄は管理職（配属されていれば栄養士）が記入。「高リスク」または、「栄養面で専門見地の意見が必要」等、事業所での対策立案が難しい場合はエリア栄養士に相談する。
✓医療的な分析が必要な場合は看護師が記入する。

10日頃

情報分析

ホーム長（生活相談員）

ケアマネジャー　看護師

カスタムカンファで話し合う順番を決定する。
（状態変化なく現状のケアを継続できる方を先に話し合う）
議事録に事前入力（「対策」「評価」以外の項目対策）し印刷する。
※議事録：アセスメント管理システムの『課題などの検討記録』

第2週

1回目 カスタムカンファ

p6の対象者・内容を①、②のパターンで話し合う。
①状態変化なく、ご要望のない方については、現状のケアを継続することに問題がないか確認。問題なければ見直しの必要ない旨記を記録する。
②それ以外のケアの見直しを必要とする方についてはegakuの画面をモニター共有して全員で見ることで課題の共有を行う。
・援助見直しの必要性を協議する。
・援助見直しに伴う環境整備／補助具を検討する。
・暫定援助スケジュールを作成する。

ケアスタッフの提案や意見は前向きに検討しよう！

カンファ後すぐ

議事録作成

生活相談員（ホーム長）

議事録を完成（「対策」の項目まで入力）する。
対策を実施していくことになるため、速やかに職員に共有する。

利用者・家族への説明

ホーム長（生活相談員）

ケアマネジャー

1回目で決まった「対策」をご利用者さま、家族に説明し、援助可否の判断をする。承諾が得られれば「対策」を実践し、その有用性を観察する。

2週目 3週目

ケア実施

ケアスタッフ　看護師

モニタリング対象者に対して、
1回目の結論に沿ったケアを実施する。

2週目 3週目

モニタリング

ホーム長（生活相談員）

ケアマネジャー　看護師

情報収集シートに書かれている利用者の**「能力向上」「QOL向上」の提案の可能性**を検討する。また、**【カスタムメイドケアサポート】で乖離は解消したか、介入によりご利用者さまにどんな変化が生じているか**を観察する。

第４週

2回目 カスタムカンファ

❶モニタリング対象者の評価を行う。
（**【カスタムメイドケアサポート】**で乖離は解消しているか、介入は適切か）
❷暫定プラン運用中の利用者に対し、必要であれば正式プランに変更。
❸**QOL向上につながる提案や課題、栄養マネジメント**について話し合う。
決定事項は「評価」に記載。対策に「観察」が必要であれば、決定するのは次月1回目のカスタムカンファとなる（「前月の対象者」に該当）
❹決定内容は**翌月のプランに反映**し、サ担会議の議題とする。

カンファ後すぐ

議事録作成

生活相談員（ホーム長）

議事録を完成させ、印刷。職員と共有した後に保管する。